P-03

Mise en place d'un système d'approvisionnement basé sur le don bénévole dans un contexte Ébola et post-Ébola à N'Zérékoré en Guinée. Données préliminaires de l'expérience d'Alima-NGO

Rigobert Kazadi Kabongo[1,*], Hamani Samba[1], Pauline Guilavogui[1], Francis Kamano[2], Solenne Barbe[1], Susan Shepherd[1], Ali Ouattara[1], Richard Kojan[1]

[1] *Alima-NGO, Dakar, Sénégal*

[2] *Alima-NGO, N'Zérékoré, Guinée*

[*] *Auteur correspondant.*

Adresse e-mail : rigobertkazadi@alima-ngo.org (R.K. Kabongo)

Contexte L'épidémie d'Ébola de 2015 avait engendré une méfiance légitime vis-à-vis des fluides biologiques aussi bien dans la population qu'auprès des professionnels de santé à N'Zérékoré. Le don de sang était devenu difficile avec une inadéquation entre l'offre et la demande au niveau de l'hôpital régional. Plus de stock de sang, tout se limitait au don direct dans les situations d'urgence rendant ainsi inefficace la réponse aux urgences transfusionnelles sur l'hôpital en général et en pédiatrie en particulier. En 2015, dans ce contexte, 2071 donneurs ont été testés avec une positivité au VIH de 4,1 %.

Objectif Rendre disponible du sang sécurisé pour les patients de l'hôpital de N'Zérékoré en général et particulièrement ceux de la Pédiatrie dans un contexte Ébola et post-Ébola.

Méthodologie Dès janvier 2016, l'ONG Alima a lancé une mobilisation sociale pour le don bénévole de sang en collaboration avec le ministère de la santé et les autorités locales. Des campagnes de sensibilisation ont été menées auprès des populations de N'Zérékoré de janvier à avril 2016, après lesquelles des collectes de sang ont été effectuées.

Résultats Un total de 208 personnes ont fait don bénévolement amenant la proportion du don bénévole à 26 % ($n = 796$). Chaque donneur a fait un seul don. Le ratio homme/femme a été de 3,42, la prévalence VIH de 2 % pour les donneurs bénévoles et de 2,4 % pour l'ensemble des donneurs.

Commentaires Cette campagne a permis de créer un stock de sang facilitant ainsi l'amélioration de la réponse aux urgences transfusionnelles. En plus, la prévalence VIH passe de 4,1 % ($n = 2071$) en 2015 à 2,4 % ($n = 796$) pour les 4 premiers mois de 2016. L'action mérité d'être poursuivie jusqu'à satisfaction totale de besoins en sang par le don bénévole. Ceci permettra d'améliorer la sécurité transfusionnelle à N'Zérékoré.

Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2016.08.045

Thème 04 – Dossiers transfusionnels

P-04

Complétude du dossier transfusionnel en pré-interventionnel : évaluation des pratiques professionnelles (EPP)

Dominique Ballion[*], Evelyne Signac, Sophie Pujol, Isabelle Roger, Virginie Moisset, Maryse Puntous, Vanessa Augis, Marie-Chantal Dubois, Anne Sauvage

CHU de Bordeaux, Bordeaux, France

[*] *Auteur correspondant.*

Adresse e-mail : dominique.ballion@chu-bordeaux.fr (D. Ballion)

Contexte Un dossier transfusionnel incomplet au bloc opératoire peut générer un retard de prise en charge transfusionnelle, notamment en contexte d'urgence. L'analyse des dysfonctionnements transfusionnels en 2015 au CHU de Bordeaux montre que parmi les anomalies concernant la gestion du dossier transfusionnel, 58 % sont en lien avec un défaut de complétude (documents absents ou avec une identité patient discordante). Un constat d'écart de pratique avait été observé par l'équipe d'infirmiers anesthésistes (IADE) prenant en charge des patients de spécialités chirurgicales (chirurgie plastique, maxillo-faciale et ORL).

Méthode et outils Une EPP a été réalisée sous forme d'audit de dossiers. Un outil de recueil (grille) a été élaboré reprenant les éléments du référentiel de constitution du dossier transfusionnel. L'objectif était d'améliorer la présence et la complétude de ce dossier en pré-interventionnel.

Résultats Un audit de 28 dossiers de patients pris en charge pour une chirurgie potentiellement hémorragique a été effectué par l'équipe d'IADE sur un mois. On retrouve 10 dossiers transfusionnels présents sur 28, soit 36 %. Pour les résultats de groupes sanguins, les documents sont présents dans 19 cas sur 28, soit 68 %. Les résultats de RAI sont présents dans 15 cas sur 28 soit 54 %. Ces résultats d'examens immuno-hématologiques ont été rangés dans le dossier anesthésie. Aucune discordance d'identité patient n'a été relevée.

Actions Une présentation des résultats a été réalisée aux équipes d'encadrement des blocs et des secteurs de soins concernés en pré-interventionnel pour la préparation du dossier. Des formations aux IDE référents en hémovigilance sur la complétude du dossier transfusionnel ont été réalisées au niveau de chaque secteur du pôle (chirurgie et consultations pré anesthésie). Une réévaluation est prévue fin 2016 avec un nouvel audit de dossiers transfusionnels en pré-interventionnel.

Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2016.08.046

Thème 05 – Formation

P-05

Chambre des erreurs en hémovigilance : un véritable outil pédagogique

Philippe Berger[*], Florence Barbancon, Fabien Chardain

CH Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne, France

[*] *Auteur correspondant.*

Adresse e-mail : berger.philippe.51240@orange.fr (P. Berger)

Introduction À l'occasion de la 5e édition de la semaine sécurité des patients, la cellule qualité (CQ) de l'établissement a proposé au personnel de santé (PS) (professionnels [PR] et étudiants [ET] médicaux et paramédicaux, médico-technique et administratif [PMA]) de venir visiter la « chambre des erreurs » largement consacrée cette année à l'hémovigilance. L'objectif était d'amener les professionnels à développer leurs capacités de détection et d'analyse des erreurs afin de renforcer la sécurité au sein de l'établissement.

Méthode La « chambre des erreurs » était composée d'une « salle de soins » et d'une « chambre patient », composée entre autre d'un lit avec mannequin, d'un dossier transfusionnel, de produits sanguins labiles (en cours d'administration et en attente). . . La chambre et la salle de soins, ouvertes durant 2,5 jours ont ainsi été reconstituées à partir d'une liste de 41 erreurs portant essentiellement sur l'hémovigilance mais aussi sur l'hygiène, la sécurité, le circuit du médicament et l'identitovigilance. Le PS cherchait les erreurs et pouvait échanger avec la CQ sur cet atelier. La fréquence de repérage des erreurs a été analysée par thème et par catégorie de PS. Une restitution a été diffusée via l'Intranet de l'hôpital.

Résultats Cent trente-six PS ont participé (PR : 54,4 % ; ET : 39 % ; PMA : 6,6 %). Toutes catégories de PS confondues, le nombre médian d'erreurs repérées a été de 16 soit 38 % des erreurs : 46 % des 17 erreurs concernant l'hygiène, la sécurité, le circuit du médicament et seulement 32 % des 24 erreurs concernant l'hémovigilance. La catégorie de PS qui a trouvé le plus d'erreurs a été celle des PR (41 % d'erreurs totales trouvées et 37 % parmi celles sur l'hémovigilance).

Conclusion Ce concept de « chambre des erreurs » est utilisé dans de nombreux centres hospitaliers. Il permet de sensibiliser de façon efficace les PS à la gestion des risques. L'aspect ludique a de plus facilité les échanges avec les PS sur un sujet « sensible » : l'hémovigilance.

Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2016.08.047